Клинические рекомендации

Аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K07.0** — Основные аномалии размеров челюстей **K07.1** — Аномалии челюстно-черепных соотношений **K07.4** — Аномалия прикуса неуточненная **Q18** — Другие врожденные аномалии [пороки развития] лица и шеи
Пациенты	взрослые
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 29.12.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/779_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Термины и определения 3

2.2 Классификация 3

2.3 Этиология 4

2.4 Клиническая картина 4

3. Диагностика 4

3.1 Жалобы и анамнез 4

3.2 Осмотр и антропометрические измерения лица 5

3.3 Лабораторные исследования перед операцией 5

3.4 КТ лицевого черепа 5

3.5 МРТ височно-нижнечелюстного сустава 5

3.6 Консультации специалистов 5

4. Лечение 5

4.1 Общие принципы 6

4.2 III класс: избыточный рост нижней челюсти 6

4.3 III класс: недоразвитие верхней челюсти (нормальный или гиподивергентный тип роста) 6

4.4 III класс: избыток нижней и недоразвитие верхней челюсти 6

4.5 II класс: избыток верхней (гипердивергентный тип роста) и недоразвитие нижней челюсти 7

4.6 II класс: недоразвитие нижней челюсти 7

4.7 Сужение верхней челюсти, перекрёстная окклюзия 7

4.8 Вертикальная резцовая дизокклюзия 7
4.9 Асимметричные аномалии 7
4.10 Иное лечение 7
4.11 Послеоперационное ведение 8
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке 8
5.1 Показания к госпитализации 8
5.2 Показания к выписке пациента 9
5.3 Медицинская реабилитация 9
5.4 Профилактика и диспансерное наблюдение 9
5.5 Факторы, влияющие на исход лечения 9
6. Источник и актуальность 9
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 10

1. Основные положения

- Зубочелюстная аномалия (деформация) — диспропорция развития челюстей с функциональными и эстетическими нарушениями; может затрагивать челюсти, скуловые кости, структуры носа и другие кости лицевого черепа.
- Всем пациентам показана консультация оториноларинголога. При нарушении носового дыхания оценивают состояние ЛОР-органов и функцию внешнего дыхания (передняя активная риноманометрия, акустическая ринометрия), а по показаниям выполняют хирургическую коррекцию внутренних структур носа.
- Обязательны КТ лицевого черепа (КЛКТ или МСКТ) и МРТ височно-нижнечелюстного сустава.
- Основным методом лечения скелетных аномалий является хирургический (ортогнатические операции) в сочетании с ортодонтической подготовкой до операции и коррекцией после неё.
- Операцию у пациентов **младше 18 лет** согласуют с ортодонтом с учётом окончания роста.
- Госпитализация плановая, в круглосуточный стационар челюстно-лицевой хирургии.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Термины и определения

Термин	Определение
Аномалия	врождённое отклонение от нормы или общей закономерности
Деформация	изменение размеров, формы и конфигурации кости от внешних или внутренних факторов
Окклюзия	вид смыкания зубных рядов
Прикус	соотношение челюстей в положении центральной окклюзии
Дистальная окклюзия	нижний зубной ряд смещён назад относительно верхнего, резцовая дизокклюзия, нарушение соотношения боковых зубов в сагиттальном направлении
Мезиальная окклюзия	нижняя челюсть смещена вперёд относительно верхней
Вертикальная резцовая дизокклюзия	нет окклюзионных контактов между резцами
Ортогнатическая хирургия	нормализация формы, размеров, положения и соотношения челюстей; включает и приёмы для профилактики нарушения носового дыхания
Гениопластика	остеотомия подбородочного отдела нижней челюсти для изменения контуров подбородка, по эстетическим показаниям

2.2 Классификация

Рабочая классификация скелетных зубочелюстных аномалий

1. **по типу окклюзии в сагиттальной плоскости**: дистальная или мезиальная окклюзия;
2. **по типу окклюзии в трансверсальной плоскости**: перекрёстная окклюзия;
3. **по типу окклюзии в вертикальной плоскости во фронтальном участке**: вертикальная резцовая дизокклюзия;
4. **по межчелюстному соотношению**: II скелетный класс (дистальный прикус), III скелетный класс (мезиальный прикус), сужение челюсти (перекрёстная окклюзия);
5. **по симметричности**: симметричная, асимметричная.

2.3 Этиология

Патология размеров и формы челюстей наблюдается при

1. наследственной предрасположенности и генетических заболеваниях;
2. врождённых аномалиях челюстно-лицевой области: расщелины губы, альвеолярного отростка и нёба, гемифациальная микросомия, синдромы Робена и Гольденхара;
3. нарушениях развития височно-нижнечелюстных суставов;
4. травмах челюстей с поражением зон роста;
5. рахите, нарушениях обмена кальция, эндокринопатиях.

Менее значимые причины

1. нарушение носового дыхания;
2. макроглоссия;
3. неправильное грудное вскармливание;
4. осложнения кариеса, недостаточная жевательная нагрузка, связанная с диспропорцией размеров зубов и отдельных участков челюстей.

Согласно современным представлениям, причинами зубочелюстных аномалий могут быть также

1. воспалительные и опухолевые процессы;
2. факторы внешней среды;
3. парафункции и вредные привычки.

2.4 Клиническая картина

У взрослых клиническая картина, как правило, сложнее, чем у детей: к аномалии присоединяются потеря зубов, деформация зубных рядов и челюстей, функциональная перегрузка пародонта, нарушения окклюзии.

---

3. Диагностика

Диагноз устанавливается на основании

1. анамнеза;
2. клинической оценки состояния пациента, местного и стоматологического статуса;
3. оценки моделей зубных рядов;
4. антропометрического анализа;
5. лучевых методов исследования: ОПТГ, ТРГ, КЛКТ или МСКТ, МРТ.

Дополнительно оценивают

1. соматический статус;
2. психоневрологический статус при нелабильной психике.

3.1 Жалобы и анамнез

Выяснить жалобы на

1. изменение конфигурации челюстей или лица, асимметрию челюстей и лица;
2. частичную потерю зубов;
3. затруднение движений нижней челюсти и жевания;
4. хруст, щелчки, боль в височно-нижнечелюстных суставах;
5. нарушение носового дыхания;
6. реже — дефект речи.

3.2 Осмотр и антропометрические измерения лица

Начать с оценки симметрии лицевого скелета и черепа, определения прикуса и антропометрических измерений лица.

Видимая деформация, асимметрия лица, нарушение окклюзии и межчелюстных соотношений — первичное звено обследования. Антропометрия объективно оценивает выраженность аномалии, гипсовые модели зубных рядов — прикус.

3.3 Лабораторные исследования перед операцией

При подготовке к операции — лабораторные исследования, чтобы исключить сопутствующие заболевания.

3.4 КТ лицевого черепа

КТ лицевого отдела черепа (КЛКТ или МСКТ), с трёхмерной реконструкцией или без неё, выполняется у всех пациентов; шаг или толщина среза — **не более 0,5 мм**. Без КЛКТ или МСКТ диагностика невозможна.

3.5 МРТ височно-нижнечелюстного сустава

МРТ височно-нижнечелюстного сустава выполняется у всех пациентов для оценки целостности и положения суставного диска.

3.6 Консультации специалистов

Всем пациентам показана консультация оториноларинголога: он оценивает состояние ЛОР-органов и предупреждает осложнения с их стороны.

При нарушении носового дыхания оценивают функцию внешнего дыхания методами передней активной риноманометрии и акустической ринометрии.

Консультация ортодонта необходима каждому пациенту, поскольку хирургическое лечение всегда сопровождается ортодонтической подготовкой и коррекцией после операции.

Консультация генетика рекомендована всем для выявления синдрома или нарушения костного метаболизма.

Перед операцией необходима консультация анестезиолога-реаниматолога: операции травматичны, возможна значительная кровопотеря и гемотрансфузия.

Перед операцией стоматолог-терапевт проводит подготовку зубов.

Стоматолог-ортопед осматривает всех пациентов: оценивает дефекты зубных рядов и окклюзионные соотношения.

---

4. Лечение

Рекомендованным методом лечения скелетных зубочелюстных аномалий является хирургический.

Противопоказанием являются тяжёлые заболевания в стадии декомпенсации. После их лечения операция становится возможной.

Пациентам **младше 18 лет** операцию согласуют с ортодонтом с учётом окончания роста, чтобы предупредить рецидив.

4.1 Общие принципы

Единого универсального метода не существует: объём операции планируют индивидуально с учётом типа и выраженности аномалии, этнической принадлежности и возраста.

Лечение направлено на устранение аномалии и создание условий для нормальной работы зубочелюстной системы. Независимо от степени внешней аномалии, перед лечением оценивают параметры всего лицевого скелета.

Перед операцией планируют объём и методики вмешательства.

Перемещение челюстей и изменение мягких тканей лица рассчитывают до операции в специализированных компьютерных программах.

Во время ортогнатической операции применяют жёсткую фиксацию титановыми пластинами и винтами: она обеспечивает стабильный результат и снижает риск рецидива.

Хирургическое лечение сочетают с ортодонтической подготовкой до операции и ортодонтической коррекцией после неё.

Этапы комбинированного лечения

1. как правило, лечение трёхэтапное: ортодонтическая подготовка, ортогнатическая операция, завершающее ортодонтическое лечение;
2. при выраженных аномалиях возможно двухэтапное лечение: сначала ортогнатическая операция, затем завершающая ортодонтическая коррекция.

В некоторых случаях применяют метод «surgery first», без предоперационной ортодонтической подготовки.

4.2 III класс: избыточный рост нижней челюсти

Показана двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для уменьшения её размеров.

При чрезмерном размере подбородочного отдела выполняется редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.3 III класс: недоразвитие верхней челюсти (нормальный или гиподивергентный тип роста)

Всем пациентам рекомендована остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная.

При чрезмерном размере подбородочного отдела выполняется редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.4 III класс: избыток нижней и недоразвитие верхней челюсти

Объём хирургического вмешательства

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, для увеличения верхней челюсти;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для уменьшения нижней челюсти;
3. при большом подбородочном отделе — редукционная гениопластика по эстетическим показаниям.

4.5 II класс: избыток верхней (гипердивергентный тип роста) и недоразвитие нижней челюсти

Объём хирургического вмешательства

1. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, возможна сегментарная, для уменьшения верхней челюсти;
2. двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для увеличения нижней челюсти;
3. остеотомия подбородочного отдела по эстетическим показаниям.

При выраженной «десневой улыбке» выполняется ротация верхней челюсти против часовой стрелки.

4.6 II класс: недоразвитие нижней челюсти

Показана двусторонняя межкортикальная скользящая остеотомия нижней челюсти (BSSO) для увеличения её размеров.

Всем пациентам рекомендована также остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I.

При недостаточном размере подбородочного отдела выполняется увеличивающая гениопластика по эстетическим показаниям.

4.7 Сужение верхней челюсти, перекрёстная окклюзия

Лечебная тактика

1. оценить возраст и степень сращения нёбного шва;
2. вместе с ортодонтом решить, возможно ли ортодонтическое расширение;
3. при сращённом шве или невозможности расширения — остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I и по срединному нёбному шву с дистракционным аппаратом; величину расширения определяет ортодонт.

4.8 Вертикальная резцовая дизокклюзия

Объём хирургического вмешательства

1. сегментарная остеотомия верхней челюсти с ротацией фронтального фрагмента из 4 или 6 зубов для предотвращения рецидива в послеоперационном периоде;
2. специальная ортодонтическая подготовка: создание промежутков (трем) между зубами в местах планируемой остеотомии, чтобы не повредить корни зубов;
3. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела.

4.9 Асимметричные аномалии

Лечебная тактика

1. по КЛКТ или МСКТ в специализированной программе оценить возможную послеоперационную деформацию;
2. остеотомия верхней челюсти по типу Ле Фор I, BSSO, остеотомия подбородочного отдела по эстетическим показаниям; при симметричном положении одной из челюстей — одночелюстная операция.

Остаточную асимметрию после перемещения челюстей устраняют краевой резекцией или аугментацией.

4.10 Иное лечение

При нарушении носового дыхания по показаниям выполняется хирургическая коррекция внутренних структур носа.

При патологии височно-нижнечелюстного сустава

1. артроцентез;
2. артролаваж;
3. диагностическая артроскопия.

Для улучшения эстетических параметров оценивают показания к

1. липосакции;
2. липофилингу;
3. платизмопластике;
4. ботулинотерапии;
5. другим методам пластической хирургии.

4.11 Послеоперационное ведение

В раннем послеоперационном периоде

1. **межчелюстная эластическая тяга**: накладывается, как правило, **в первые сутки** и полностью исключает открывание рта, удерживая челюсти в правильном положении;
2. **местно холод**: **в первые сутки** для профилактики отёка;
3. **лекарственная терапия**: курс антибактериальной, противоотёчной и обезболивающей терапии;
4. **гигиена полости рта**: ежедневно.

В первые дни в послеоперационных ранах могут оставлять дренажи; их удаляют на 1–3-и сутки по мере уменьшения отделяемого.

Ограничение открывания рта

1. **операции на верхней челюсти**: как правило, **2 недели**;
2. **ортогнатические операции на нижней челюсти**: около **3 недель**.

После снятия межчелюстной эластической тяги для профилактики ограничения открывания рта рекомендованы лечебная физкультура и физиотерапия.

Для постепенного увеличения амплитуды пациент открывает и закрывает рот перед зеркалом, выполняет движения нижней челюсти вперёд-назад и в стороны; амплитуду можно увеличивать указательным и большим пальцами, расположенными на режущих краях верхних и нижних резцов.

Как правило, через **3–4 недели** после операции пациента направляют к ортодонту на окончательный этап аппаратной ортодонтической коррекции.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации и выписке

5.1 Показания к госпитализации

Ортогнатические операции выполняются челюстно-лицевыми хирургами в круглосуточном стационаре, госпитализация плановая.

Показания к плановой госпитализации

1. необходимость ортогнатической операции или невозможность ортодонтической коррекции в амбулаторных условиях;
2. невозможность выполнения диагностических или лечебных манипуляций в амбулаторных условиях.

Продолжительность госпитализации, как правило, от нескольких дней до двух недель и зависит от течения ближайшего послеоперационного периода.

5.2 Показания к выписке пациента

1. отсутствие показаний к дальнейшему лечению в стационаре;
2. перевод в другое лечебное учреждение;
3. требование пациента или его законного представителя;
4. несоблюдение предписаний или правил внутреннего распорядка, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих.

После выписки пациент наблюдается амбулаторно или в условиях дневного стационара.

5.3 Медицинская реабилитация

После операции показаны реабилитационные мероприятия до полного социального и физического восстановления.

Специфической реабилитации нет. Помощь оказывает команда: челюстно-лицевой хирург, ортодонт, анестезиолог-реаниматолог, при необходимости невролог, офтальмолог, оториноларинголог, генетик, логопед.

5.4 Профилактика и диспансерное наблюдение

При симптомах аномалии костей черепа и лица показана консультация челюстно-лицевого хирурга. Специфической профилактики нет; она заключается в плановом рациональном ведении беременности, а при выявлении аномалии — в обследовании у ортодонта.

После операции челюстно-лицевой хирург и ортодонт осматривают пациента **не реже раза в 6 месяцев**.

При подозрении на рецидив, вторичную деформацию или ухудшение местного, неврологического, офтальмологического статуса выполняют

1. КТ всего черепа;
2. МРТ головного мозга;
3. ЭЭГ;
4. другие исследования по клинической картине.

5.5 Факторы, влияющие на исход лечения

Отрицательно влияют на исход лечения

1. инфекционные осложнения;
2. несоблюдение местной контактной криотерапии;
3. плохая гигиена полости рта;
4. нарушение диеты и ограничения жевательной активности;
5. несоблюдение ношения межчелюстной эластической тяги;
6. несоблюдение лечебной физкультуры;
7. пропуск контрольных осмотров и других рекомендаций врача.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Врожденные и приобретенные аномалии и деформации зубочелюстной системы и лицевого черепа»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 29.12.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее декабря 2026 года
Код в рубрикаторе	779_1 · открыть текст КР ↗

Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии
Пациенты	Взрослые

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Рекомендации для взрослых, но в разделе 3 есть указание об операциях у пациентов младше 18 лет — с согласованием с ортодонтом.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания (Le Fort I, BSSO); цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту.